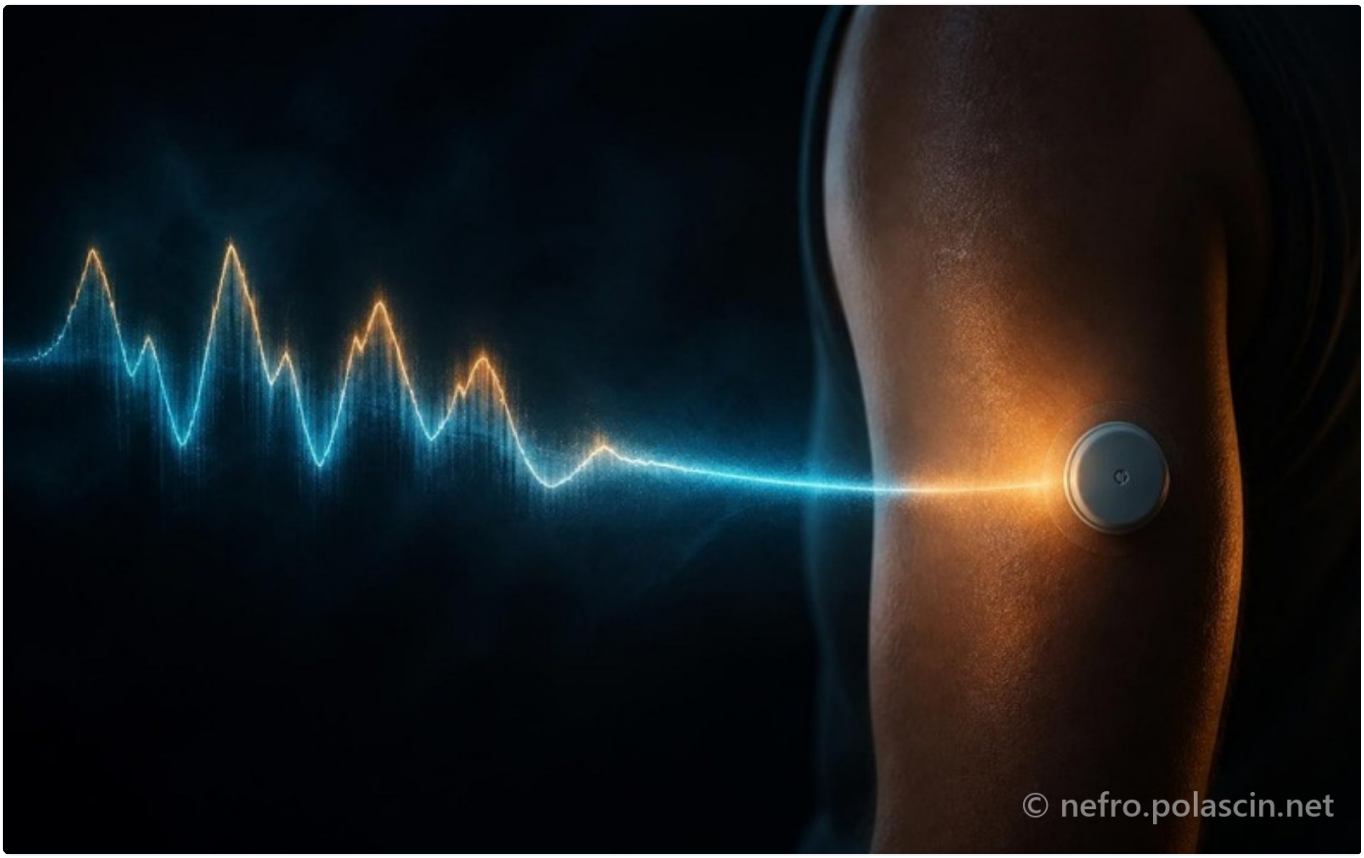
Kontinuálne monitorovanie glukózy môže pomôcť aj pacientom s diabetom 2. typu bez inzulínu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 09.06.2026



Ilustračná scéna. Aj bez inzulínu môže priebežný obraz glykémie zmeniť každodenné rozhodnutia pacienta.

Kontinuálne monitorovanie glukózy (CGM) je už roky štandardnou súčasťou starostlivosti pri diabete 1. typu a pri diabete 2. typu liečenom inzulínom. Nové údaje zo štúdie CONNECT však ukazujú, že významný prínos môže mať aj u dospelých s diabetom 2. typu, ktorí inzulín nepoužívajú.

Výsledky odzneli na kongrese **American Diabetes Association 2026 Scientific Sessions** v New Orleans. Podľa autorov štúdie môže CGM zlepšiť kontrolu hyperglykémie, pomôcť pacientom lepšie pochopiť vplyv stravy, pohybu a liekov na glykémiu a potenciálne znížiť riziko dlhodobých komplikácií diabetu.

Prečo je táto otázka dôležitá

U pacientov s diabetom 2. typu bez inzulínovej liečby sa CGM doteraz nepoužíva tak bežne ako u pacientov liečených inzulínom. Dôvodom je aj nedostatok veľkých randomizovaných štúdií, ktoré by jasne preukázali jeho prínos v tejto skupine.

Zároveň však veľká časť pacientov s diabetom 2. typu nedosahuje cieľové hodnoty glykémie napriek liečbe modernými liekmi, ako sú inhibítory SGLT2, agonisty receptora GLP-1 alebo iné antidiabetiká. Tu môže CGM pomôcť ako praktický nástroj, ktorý ovplyvňuje nielen liečbu, ale aj každodenné správanie pacienta.

Štúdia CONNECT

Multicentrická štúdia **CONNECT** zahŕňala 283 dospelých pacientov s diabetom 2. typu, ktorí nepoužívali inzulín. Účastníci pochádzali z 22 ambulancií primárnej starostlivosti v Spojených štátoch.

Pacienti boli náhodne rozdelení do dvoch skupín:

- **145 pacientov** používalo CGM zariadenie Dexcom G7,

- **138 pacientov** pokračovalo v bežnej starostlivosti so štandardným glukomerom.

Obe skupiny pokračovali v predchádzajúcej antidiabetickej liečbe, dostali edukáciu o strave a pohybe a absolvovali pravidelné kontroly.

Priemerný vek pacientov bol 60 rokov. Medián trvania diabetu bol 10 rokov. Priemerná vstupná hodnota HbA1c bola 8,8 %, pričom 31 % pacientov malo HbA1c aspoň 9 %. Priemerný BMI bol 33 kg/m². Inhibítor SGLT2 užívalo 37 % pacientov a liečbu založenú na inkretínoch, napríklad agonistu receptora GLP-1, 40 %.

Výraznejšie zníženie HbA1c

Po 26 týždňoch dosiahli pacienti používajúci CGM podstatne väčšie zlepšenie glykémie než pacienti v skupine bežnej starostlivosti.

HbA1c sa znížil:

- o **1,6 %** v skupine s CGM,
- o **0,7 %** v skupine bežnej starostlivosti.

Rozdiel medzi skupinami predstavoval **0,9 %** a bol štatisticky významný.

Najväčší prínos mali pacienti s najvyššou vstupnou hodnotou HbA1c. U pacientov s HbA1c pod 8 % bol rozdiel medzi CGM a bežnou starostlivosťou menší. Naopak, u pacientov s HbA1c aspoň 10 % klesol HbA1c o **3,1 %** pri CGM oproti **1,2 %** pri bežnej starostlivosti.

To je klinicky dôležité, pretože práve pacienti s najvýraznejšou hyperglykémiou majú najvyššie riziko vaskulárnych komplikácií.

Viac času v cieľovom rozmedzí

CGM neukazuje iba priemernú glykémiu, ale aj to, koľko času pacient trávi v cieľovom glykemickom rozmedzí.

V štúdii sa hodnotilo rozmedzie **70 až 180 mg/dl** (3,9 až 10,0 mmol/l). Pacienti s CGM strávili v tomto cieľovom rozmedzí približne o **5 hodín denne viac** než pacienti v bežnej starostlivosti.

Čas v cieľovom rozmedzí sa v skupine s CGM zvýšil z 29 % na 62 %. V skupine bežnej starostlivosti stúpol z 31 % na 42 %. Rozdiel bol štatisticky významný.

Prínos bez ohľadu na modernú farmakoterapiu

Prínos CGM sa pozoroval u pacientov užívajúcich aj neužívajúcich agonisty receptora GLP-1 a inhibítory SGLT2.

To naznačuje, že CGM nemá význam len ako doplnok pri nedostatočnej liečbe. Môže byť užitočné aj u pacientov, ktorí už dostávajú účinné moderné antidiabetiká, ale stále potrebujú lepšiu glykemickú kontrolu a spätnú väzbu v každodennom režime.

Bezpečnosť a spokojnosť pacientov

V štúdii neboli hlásené žiadne prípady ťažkej hypoglykémie ani v jednej skupine. Výskyt závažných nežiaducich udalostí nesúvisiacich s CGM bol podobný.

Pacienti používajúci CGM zároveň hlásili vyššiu spokojnosť s manažmentom diabetu a nižšiu mieru diabetického distresu. Má to praktický význam: diabetes do veľkej miery riadi sám pacient, a ak lepšie vidí dôsledky svojich rozhodnutí, môže aktívnejšie upravovať stravu, pohyb a adherenciu k liečbe.

Význam pre verejné zdravie

Výsledky majú podľa odborníkov význam aj pre verejné zdravie. Pacienti s diabetom 2. typu bez inzulínu tvoria veľkú časť populácie s diabetom. V USA ide približne o tri štvrtiny dospelých s diabetom 2. typu, teda asi 20 miliónov ľudí.

Keďže CGM v tejto skupine často nie je hradené poisťovňami, nové dáta môžu podporiť diskusiu o širšej dostupnosti tejto technológie. Štúdiu však financovala spoločnosť Dexcom, výrobca použitého systému CGM, a to treba pri interpretácii výsledkov zohľadniť.

Čo z toho vyplýva pre prax

Výsledky štúdie CONNECT naznačujú, že CGM môže byť užitočné aj u pacientov s diabetom 2. typu, ktorí nepoužívajú inzulín, najmä ak majú zvýšené HbA1c napriek liečbe a režimovým odporúčaniam.

Najväčší praktický prínos možno očakávať u pacientov s výraznejšou hyperglykémiou, nízkym časom v cieľovom rozmedzí, neistotou v stravovacích návykoch alebo potrebou lepšej spätnej väzby o účinku liekov a životného štýlu.

Samotný prístroj však nestačí. Hodnotu má až vtedy, keď pacient a zdravotnícky tím dokážu namerané údaje správne interpretovať a premietnuť ich do konkrétnych rozhodnutí.

Záver

Nové dáta zo štúdie CONNECT posúvajú diskusiu o CGM za hranice inzulínovej liečby. U pacientov s diabetom 2. typu bez inzulínu viedlo kontinuálne monitorovanie glukózy k výraznejšiemu poklesu HbA1c, predĺženiu času v cieľovom rozmedzí, vyššej spokojnosti s liečbou a nižšiemu diabetickému distresu.

Ak sa tieto výsledky potvrdia aj v ďalších štúdiách a v bežnej klinickej praxi, CGM sa môže stať dôležitým nástrojom individualizovanej starostlivosti o širšiu skupinu pacientov s diabetom 2. typu.

> **Poznámka – prepočet jednotiek glukózy.** Hodnota v mmol/l uvedená v zátvorke je prepočítaná z mg/dl a zaokrúhlená na jedno desatinné miesto. Pre glukózu v krvi platí:
>
> - mmol/l = mg/dl ÷ 18 (čiže mg/dl × 0,0555),
> - mg/dl = mmol/l × 18.

Zdroj: *Medscape, „CGM Monitoring Benefits Extend to Non-Insulin-Using T2D“. medscape.com*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=kontinualne-monitorovanie-glukozy-diabetes-2-typu-bez-inzulinu · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.